

림프종 진단 첫 30일

아형 · 병기 · 항암치료 흐름 이해

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 11

완전판 · 2026년 10월 개정 2판

림프종은 이름이 같아도 아형에 따라 ‘지켜보기’부터 ‘즉시 치료’까지
다릅니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — B-Cell Lymphomas / Hodgkin Lymphoma / T-Cell Lymphomas, Version 4.2026(B세포 림프종 기준) 외 국내 자료(본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 책의 사용법

이 책은 처음부터 끝까지 읽는 책이 아닙니다. **지금 내 상황에 필요한 장만 펴서 쓰는 책**입니다.

지금 내 상황	먼저 펼 곳
방금 진단을 들었고 머리가 하얗다	1장 「먼저 구분하세요」 → 「진단 뒤 72시간」
몸에 이상 신호가 있다	「기다리지 않는 신호」 (응급 상자)
다음 주에 진료가 잡혀 있다	해당 치료 장 + 워크북 「진료 기록지」
검사 결과지를 받았다	PART 1의 병리·검사·병기 장
돈·보험·회사가 걱정이다	PART 5 「돈 · 서류 · 제도」
마음이 무너질 것 같다	PART 4 「마음 돌보기」
가족으로서 무엇을 해야 할지 모르겠다	PART 4 「보호자에게」

각 장의 구성은 같습니다.

- **30초 요약** — 바쁠 때는 이 상자만 읽어도 됩니다.
- **본문** — 왜 그런지, 무엇을 확인하는지.
- **오늘 물어볼 질문** — 진료실에 가져갈 질문은 장마다 3개 이내로 골랐습니다.
- **기록칸** — 들은 내용을 그 자리에서 적습니다. 보호자가 적어도 좋습니다.
- **🆘 응급 상자** — 기다리지 말고 연락해야 하는 신호입니다.

이 책의 표시:  확정된 정보 ·  검사·결정 대기 ·  아직 모름/확인 필요.
색이 아니라 기호로 구분했으니 흑백으로 인쇄해도 그대로 쓸 수 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 아형이 치료를 정합니다

30초 요약

- 림프종은 **호지킨 림프종**과 **비호지킨 림프종**으로 나뉘고, 비호지킨은 다시 수십 가지 아형이 있습니다.
- 크게 **빨리 자라는(공격성) 림프종**은 곧바로 치료하고, **천천히 자라는(저등급) 림프종**은 증상이 없으면 **관찰**하기도 합니다.
- 진단에는 **림프절 절제 또는 굵은 바늘(중심부) 조직검사**가 필요합니다. 가는 바늘 세포검사만으로는 아형을 정하기 어렵습니다. 조직검사 전에는 **스테로이드를 임의로 먹지 마세요** — 림프종 세포가 줄어 진단이 어려워질 수 있습니다.
- 리툰시맙 같은 항CD20 치료 전 B형간염 검사**는 한국 환자에게 특히 중요한 안전 단계입니다.

아형(예)	속도	흔한 첫 치료
미만성 거대B세포 림프종(DLBCL)	빠름	항CD20 항체 + 항암(일부 고위험은 항체-약물접합체(ADC) 병용 요법)
여포성 림프종	대개 느림	저부담이면 관찰, 증상·부담 크면 치료, 국소면 방사선
변연부 림프종(MALT 등)	느림	위 MALT는 헬리코박터 제균, 실패 시 방사선
외투세포 림프종	다양	아형 특성에 맞춘 요법
소림프구성 림프종	느림	만성림프구백혈병과 같은 방식으로 관리

아형(예)	속도	흔한 첫 치료
호지킨 림프종	빠른 편, 완치율 높음	병기별 항암 ± 방사선, 진행기는 면역치료 병용 항암 범주
T세포·NK/T세포 림프종	다양	아형별 요법, 임상시험 고려

분류 기준(WHO 5판·ICC)에 따라 보고서 용어가 조금 다를 수 있습니다.
DLBCL에서는 **MYC·BCL2 재배열** 여부가 치료 상의에 특히 중요합니다.

오늘 물어볼 질문

1. 제 림프종의 정확한 아형은 무엇인가요?
2. 빨리 자라는 쪽인가요, 천천히 자라는 쪽인가요?
3. 바로 치료를 시작하나요, 관찰하나요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자

- **항암 중 38°C 이상 발열·오한** → 해열제보다 먼저 연락(호중구 감소 시 감염은 빠르게 진행)
- **눈·피부가 노래짐, 소변이 콜라색, 심한 피로**(B형간염 재활성화 가능성)
- **얼굴·목이 붓고 숨이 참**(종격동 덩이 압박)
- **등 통증 + 다리 힘 빠짐·대소변 장애**(척수 압박)
- **첫 치료 직후 소변량 감소·심한 피로·근육 경련·두근거림**(종양용해증후군)
- **CAR-T·이중특이항체 치료 후 발열, 어지럼·저혈압, 말·글씨·행동 변화, 경련**(사이토카인방출증후군·신경독성) → 즉시 치료기관 연락
- **면역치료 중 숨참·기침, 심한 설사**
- **스스로를 해치고 싶은 생각** → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 호중구 감소 중 발열은 응급입니다.
2. B형간염은 과거에 앓고 나온 사람도 항CD20 치료 중 다시 활동할 수 있습니다.
3. 큰 종격동 덩이는 기도·혈관을 누를 수 있습니다.
4. 척추·신경 압박은 시간이 중요합니다.
5. 종양용해증후군은 빨리 자라는 림프종의 첫 치료 때 생길 수 있어 수액·약으로 예방합니다.
6. 세포치료 후 부작용은 모두에게 생기지 않지만, 생기면 빠른 치료가 효과적입니다.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 조직검사 결과(아형) 확인 ② 혈액종양내과 예약 ③ 아이 계획이 있다면 **첫 항암 전** 가임력 상담 요청.

오늘 할 일 (3개)

- ☐ 병리보고서 — 아형, 면역염색, (DLBCL) MYC·BCL2 결과
- ☐ 혈액종양내과(림프종 진료) 예약
- ☐ 가임력: 남성은 **정자 동결**(첫 항암 전), 여성은 난자·배아 동결(약 2주 안팎). 공격성 림프종은 치료를 늦출 수 있는지 혈액내과와 함께 정합니다. 치료 중과 치료 후 일정 기간은 피임이 필요합니다(기간은 요법별로 확인).

이번 주 할 일

- ☐ **PET/CT**(병기·반응평가 기준), 혈액검사(LDH 젖산탈수소효소 — 종양 활동량을 짐작하는 수치)
- ☐ 필요 시 골수검사, 심장 초음파(안트라사이클린 계열 전)
- ☐ **B형간염 검사**(표면항원 HBsAg, 핵심항체 anti-HBc) → 양성이면 **예방 항바이러스제**
- ☐ C형간염·HIV 검사
- ☐ 산정특례 신청(확진일로부터 30일 이내; 관찰만 하는 경우 적용 시점 원무과 확인)

B형간염 상태별 안내

검사 결과	의미	흔한 조치
HBsAg 양성	현재 보유자	항암 전 또는 동시에 예방 항바이러스제 시작

검사 결과	의미	흔한 조치
HBsAg 음성 / anti-HBc 양성	과거 감염	항CD20 치료 때는 예방 항바이러스제가 흔히 권고됨, 또는 HBV DNA 정기 검사 (병원 방침·급여 확인)
모두 음성	감염 이력 없음	일반적 관리

> 예방 항바이러스제는 **치료가 끝난
뒤에도 일정 기간** 계속합니다.
임의로 끊지 마세요.

오늘 물어볼 질문

1. 병기 검사(PET/CT·골수검사)는 언제 하나요?
2. B형간염 검사 결과와 예방약 계획은요?
3. 가임력 보존을 할 시간이 있나요?

4장. 병기와 반응평가

30초 요약: 림프종은 PET/CT 기반 병기(Lugano)를 씁니다. 숫자보다
"림프절 몇 군데, 횡격막 위아래, 림프절 밖 장기 침범"이 중요합니다. 치료 중
·후에는 Deauville 점수(1~5)로 반응을 봅니다.

병기	쉬운 뜻
I	림프절 한 부위
II	횡격막 한쪽의 두 부위 이상
III	횡격막 위아래 양쪽

병기	쉬운 뜻
IV	림프절 밖 장기(골수·간·폐 등)에 넓게
B증상	원인 모를 38°C 이상 발열, 밤에 흠뻑 젖는 땀, 6개월에 10% 이상 체중 감소
큰 덩이(bulky)	덩이가 매우 큼 — 치료 계획에 영향
위험도 점수(IPI·FLIPI 등)	치료 강도를 정하는 참고값 — 내 남은 수명을 뜻하지 않음

국내 결과지·안내문에는 **Ann Arbor(앤 아버) 병기**로 적히기도 합니다. Lugano는 Ann Arbor를 고친 체계라 I~IV기의 뜻은 거의 같고, 숫자 뒤의 A·B는 B증상이 없음·있음을 뜻합니다.

PET 판독지 읽기

표현	쉬운 말
SUVmax	당 섭취 정도
Deauville 1~3	대개 대사적 완전반응
Deauville 4~5	남은 활동 가능성 — 추가 평가
complete metabolic response	대사적 완전반응(완치와 같은 말은 아님)

병리 체크

CD20(항CD20 치료 대상 여부), CD30(호지킨·일부 T세포), Ki-67, MYC·BCL2·BCL6(FISH), EBV.

내 기록: 아형 _ · 병기 _ · B증상 ☐ · 큰 덩이 ☐ · LDH _ · 골수 _ · HBsAg _ / *anti-HBc* _ · 예방약 _____

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

5장. 공격성 B세포 림프종(DLBCL 등)

30초 요약: 항CD20 항체 + 항암 병용(대표 예: R-CHOP), 일부 고위험군은 **ADC를 포함한 병용 요법** 범주(국내 허가·급여 확인 필요). 대개 3주 간격 6주기이며, 범위가 좁고 위험인자가 적으면 반응에 따라 4주기로 줄이기도 합니다. 중간 PET으로 반응을 확인합니다. 나이·심장·신장 기능에 따라 용량을 줄인 요법을 쓰며, **나이만으로 치료가 불가능하다고 판단하지 않습니다.**

- 뇌 재발 위험이 높은 일부는 뇌 예방 치료를 상의합니다.
- 1차 치료 뒤 **일찍 재발하거나 듣지 않으면 CAR-T 세포치료, 이중특이항체**(단독 또는 항암과 병용) 등 범주가 있습니다(순서·국내 허가·급여·시행기관 확인 필요).
- 늦게 재발했고 체력이 좋다면(국내 자료 기준 대개 70세 미만) **구제 항암 뒤 고용량 항암 + 자가조혈모세포이식**이 오래 쓰여 온 경로입니다. 이식이 어렵다면 구제 항암만 하거나 다른 선택지를 상의합니다.

1주기(21일) 달력(일반적 예시)

날	흔한 변화	대처
1~5일	스테로이드 복용 — 혈당 ↑·불면·기분 들뜸, 메스꺼움	혈당 측정(당뇨 시), 아침 복용
7~14일	백혈구 최저점(백혈구 촉진 주사 맞기도)	발열 시 즉시 연락, 손 씻기
2~3주	탈모 시작, 손발 저림, 변비	변비약, 저림 기록
21일	다음 주기 전 채혈	—

6장. 호지킨 림프종

30초 요약: 젊은 환자에게 많고 **완치율이 높은 편**입니다. 초기는 항암(±방사선), 진행기는 **항암에 PD-1 면역치료를 더하는 요법** 또는 **CD30 표적 ADC를 포함한 요법**이 1차 범주입니다(최신 근거·국내 허가·급여 확인 필요).

- 면역치료 병용 시 갑상선 기능 변화, 숨참·기침, 심한 설사 같은 면역 관련 부작용을 알려 주세요.
- 요법에 따라 폐 독성·신경 독성·생식 독성이 달라 **가임력 상담**과 함께 상의합니다.

7장. 저등급(천천히 자라는) 림프종과 관찰

30초 요약: 증상이 없고 종양 부담이 낮으면 **관찰(watch and wait)**이 표준 선택입니다. 이 단계에서 일찍 치료해도 생존이 늘지 않는다는 연구가 관찰 전략의 근거입니다. 범위가 좁은 초기(I~II기)는 **방사선만으로** 오래 조절하거나 완치를 목표로 하기도 합니다.

- 관찰 중에는 보통 3~6개월마다 진찰·혈액검사를 하고, 영상은 증상이나 변화가 있을 때 주로 합니다(병원 방침 확인).
- 관찰 기간에 불안이 커지는 것은 자연스럽습니다. 관찰은 손을 놓는 것이 아니라, **정기 검사로 몸을 살피다가 꼭 필요할 때 치료를 시작하는 방식**입니다.
- 위 MALT 림프종은 **헬리코박터 제균**에 반응하는 경우가 많고, 반응하지 않으면 방사선을 씁니다.
- 여포성 림프종에서 치료가 필요해지면 항CD20 항체(리툰시맙 등)에 벤다무스틴이나 CHOP을 더한 요법을 흔히 쓰고, 반응한 뒤 항CD20 항체만 2년 가까이 이어 가는 **유지요법**을 하기도 합니다(국내 급여 기준 확인 필요). 국내 자료에는 '소포성 림프종'이라고도 적힙니다.

관찰 중 연락 신호

- 림프절이 빠르게 커짐 □ B증상(발열·식은땀·체중 감소) □ 심한 피로·빈혈 □ 장기 압박 증상 □ 새 통증

날짜	만져지는 림프절 (cm)	체 중	증 상	다음 진료
----	---------------------	--------	--------	----------

> 가족에게: "천천히 자라는 림프종이라 지금은 치료보다 정기 검사가 더 좋은 선택이래. 변화가 생기면 그때 치료해."

8장. 방사선과 세포치료

30초 요약

- 방사선은 ① 초기 저등급 림프종의 근치 ② 항암 후 공고(남은 덩어리·큰 덩이) ③ 증상 완화에 씁니다. 요즘은 **병이 있던 부위만 좁게** 조사합니다.
- CAR-T**: 치료 후 일정 기간 치료기관 근처에 머물고, **보호자 24시간 동반**, 운전 제한(기간은 치료기관 안내)을 안내받습니다.

림프종의 3·4기는 고형암의 "전이"와 다릅니다. 공격성 B세포 림프종과 호지킨 림프종은 진행기에도 **완치를 목표로 치료하는 경우가 많고**, 저등급 림프종은 오래 조절하며 지내는 것이 목표일 수 있습니다. 아래 내용은 재발했거나 치료가 어려운 경우를 위한 것입니다.

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

치료 목표를 묻는 질문

1. 이 치료의 목표는 무엇인가요? (암 크기 줄이기 / 진행 늦추기 / 증상 줄이기)
2. 치료 효과는 언제, 어떤 검사로 확인하나요?
3. 이 치료를 받지 않거나 쉬면 어떤 일이 예상되나요?

완화의료 이용하기

- 대부분의 암 병원에 **완화의료팀(자문형)**이 있습니다. 통증, 숨참, 메스꺼움, 불면, 불안 조절을 담당 교수에게 요청하면 연결됩니다.
- 호스피스·완화의료는 입원형·가정형·자문형으로 나뉘며, 지정 기관과 이용 조건은 국립암센터 중앙호스피스센터 누리집이나 병원 사회사업팀에서 확인합니다.
- 완화医료를 받는다고 해서 항암치료를 포기하는 것이 아닙니다.

미리 생각해 둘 것(원할 때만)

- **사전연명의료의향서**: 19세 이상이면 건강할 때도 작성할 수 있습니다. 보건소·지정 등록기관에서 작성하며, 언제든지 변경·철회할 수 있습니다 (국립연명의료관리기관).

- 치료를 잠시 쉬거나 멈추는 선택도 존중되는 결정입니다. 결정은 한 번에 하지 않아도 됩니다.
- 내가 직접 말하기 어려워질 때 나 대신 의견을 전할 사람을 정해 가족에게 알려 드립니다.

2차 소견과 병원 선택

30초 요약

- 2차 소견은 담당 의사를 의심하는 일이 아니라 **큰 결정을 확인하는 일**입니다. 대부분의 의사는 자연스럽게 받아들입니다.
- 2차 소견 때문에 치료를 몇 주씩 미루지 않도록 **일정을 먼저 정하고** 움직입니다.
- 가장 중요한 준비물은 병리 슬라이드·블록과 영상 CD입니다.

2차 소견이 특히 도움이 되는 경우

- 병리 결과가 드문 조직형이거나, 병원마다 해석이 갈릴 수 있다고 들었을 때
- 수술과 비수술 치료 중 선택지가 둘 이상일 때
- 기능 보존 수술이나 드문 치료처럼 경험 많은 센터가 중요한 치료일 때
- 설명을 들었는데도 결정이 서지 않을 때

병원을 고를 때 물어볼 것

1. 이 병원에서 림프종 환자를 **다학제(여러 과가 함께 보는) 진료**로 상의하나요?
2. 제게 필요한 치료(수술·방사선·항암·임상시험 등)를 **한 병원**에서 받을 수 있나요?
아니면 연계 병원이 정해져 있나요?
3. 치료 중 밤이나 휴일에 문제가 생기면 **어디로 연락**하나요?
4. 첫 치료까지 대략 몇 주가 걸리나요?

집과의 거리도 중요한 기준입니다. 매일 가야 하는 방사선치료나 잦은 외래가 예정되어 있다면, 통원 부담과 응급 시 이동 시간을 함께 따져 보세요.

2차 소견 준비 체크리스트

- ☐ 진료의뢰서(상급종합병원은 필수)
- ☐ 병리보고서 + 슬라이드/블록 대여
- ☐ 영상 CD + 판독지
- ☐ 혈액검사 결과, 복용 약 목록
- ☐ 내가 가장 궁금한 질문 3개(워크북 「질문지」)

최신 치료와 임상시험

- 임상시험은 "마지막에 기대는 실험"만이 아닙니다. 진단 초기부터 **표준치료와 함께 고려할 수 있는 선택지**입니다.
- 임상시험에 참여해도 언제든 그만둘 수 있고, 위약(가짜약)만 단독으로 쓰는 암 임상시험은 드뭅니다. 위약이 포함되면 사전에 설명을 듣습니다.
- 연구 약값은 보통 연구 쪽이 부담하지만, 교통비·추가 방문 등 부대 비용은 확인이 필요합니다.

찾는 곳

- 담당 교수에게 "제가 참여할 수 있는 임상시험이 있나요?"라고 직접 묻기 — 가장 빠릅니다.
- 한국임상시험포털(KoNECT), 식품의약품안전처 의약품안전나라 임상시험 정보, ClinicalTrials.gov(영문)

물어볼 질문

1. 이 연구는 무엇을 비교하나요? 표준치료를 받지 못하게 되나요?
2. 방문 횟수와 검사가 얼마나 늘어나나요?

3. 중간에 그만두면 어떤 치료를 받게 되나요?

PART 3. 30일 실행 로드맵

Day 0-3 · 확인하기

- ☐ 아형 확인 ☐ 혈액종양내과 예약 ☐ 가임력 상담 요청 ☐ 연락처 저장

Day 4-7 · 검사받기

- ☐ PET/CT ☐ 혈액(LDH·간염·HIV) ☐ 골수검사(해당 시) ☐ 심장 초음파 ☐ 산정특례

Day 8-14 · 결정하기

- ☐ 병기 설명 ☐ 치료 vs 관찰 결정 ☐ B형간염 예방약 ☐ 정자·난자 동결

Day 15-21 · 준비하기

- ☐ 포트 ☐ 항암 교육(발열 시 연락) ☐ 종양용해 예방 ☐ 학업·직장 일정

Day 22-30 · 시작하기

- ☐ 첫 주기 ☐ 21일 달력·증상 일지 ☐ 관찰이라면 다음 진료 날짜 확정
-

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

감염 예방과 일상

30초 요약: 백혈구가 떨어지는 시기에는 **손 씻기, 사람 많은 곳 줄이기, 발열 시 즉시 연락**이 가장 중요합니다. 예방접종(생백신 제외)은 시기를 담당의와 상의합니다.

- 체온계는 집에 두고, 오한이 들면 바로 재기.
- 날음식은 백혈구가 낮을 때 피하라는 병원 안내를 따릅니다.
- 반려동물 배설물 처리는 다른 가족에게.
- 학업·직장: 학교에는 휴학·학업 유예 제도를, 회사에는 근무 조정을 문의하세요. 치료 일정이 나오면 3주 주기에 맞춰 계획을 세우면 편합니다.

추적

- 치료 종료 후 PET/CT로 반응을 확인하고, 이후에는 진찰·혈액검사 중심으로 추적합니다. 증상이 없을 때 잦은 CT는 대개 필요하지 않습니다.
- 장기적으로 심장·갑상선(목 방사선)·이차암 검진을 상의합니다.
- 치료 뒤 엉덩이·무릎 관절이 계속 아프면 알리세요. 드물게 스테로이드 등과 관련된 뼈 괴사(무혈성 괴사)가 생길 수 있습니다.

치료 중 흔한 증상, 집에서 할 일과 연락 기준

아래는 여러 암 치료에서 공통으로 흔한 증상입니다. **치료 병원의 안내가 항상 우선**이며, "연락" 칸에 해당하면 다음 예약까지 기다리지 마세요.

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
메스꺼움·구토	처방받은 구토 예방약을 시간 맞춰 (증상이 생긴 뒤가 아니라 미리). 조금씩 자주, 차갑고 냄새가 약한 음식, 생강차·크래커	하루 3회 이상 구토, 물도 못 마심, 24시간 소변이 거의 없음
피로	짧은 낮잠(30분 이내), 가벼운 걷기, 우선순위 정해 에너지 아끼기, 도움 요청	숨참·어지럼·심한 창백(빈혈 가능), 일상생활이 불가능
입안 혈음	부드러운 칫솔, 무알코올 가글(소금·베이킹소다 물), 자극적·뜨거운 음식 피하기	통증으로 먹거나 마시지 못함, 흰 반점·출혈, 발열 동반
변비	수분, 걷기, 처방 변비약. 진통제(마약성) 복용 중이면 변비약을 미리 함께	3일 이상 변이 없고 복통·구토, 배가 부풀
설사	수분·전해질(이온음료 희석, 미음), 기름진 음식·유제품·카페인 줄이기, 처방 지사제	하루 4~6회 이상, 밤에도 계속, 혈변, 어지럼·소변 감소, 면역치료 중 설사
불면	일정한 기상 시간, 낮잠 제한, 잠자리에서 휴대폰 멀리, 스테로이드는 아침 복용(지시대로)	2주 이상 계속, 불안·우울 동반
탈모	순한 샴푸, 짧은 머리, 모자·두건·가발, 두피 자외선 차단	— (대개 치료 후 다시 자람)
피부 발진·건조	순한 보습제 하루 2회 이상, 미지근한 물, 자외선 차단	물집·벗겨짐, 넓게 번짐, 점막(입·눈) 침범
손발 저림	찬 것 피하기(일부 약), 따뜻한 양말·장갑, 낙상 주의	단추·젓가락·걸기가 어려워짐 — 다음 투여 전에 꼭 알리기

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
식욕 저하· 체중 감소	먹을 수 있을 때 먹기, 고단백 간식, 영양 보충 음료	한 달 5% 이상 체중 감소, 평소의 절반 이하로 1주 이상

열이 나면: 항암 중 38°C 이상(병원 기준에 따라 37.8°C 이상 1시간 지속 등)은 **해열제를 먹기 전에 먼저 연락**하는 것이 원칙입니다. 열을 내리면 감염 신호를 놓칠 수 있습니다.

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

내 마음 온도계(고통 선별)

지난 1주일 동안 내 마음의 고통은 몇 점이었나요? (0 = 전혀 없음, 10 = 극심함)

날짜 점수(0~10) 가장 힘든 것(☐ 걱정 ☐ 잠 ☐ 통증 ☐ 돈 ☐ 가족 ☐ 일 ☐ 기타)

- **4점 이상**이 계속되면 다음 진료 때 점수를 그대로 말하세요. 대부분의 암 병원에는 정신건강의학과·임상심리·사회사업팀 연결 경로가 있습니다.
- 불면이 1~2주 이상 계속되면 수면 치료를 받을 수 있습니다. 잠은 치료를 건디는 체력입니다.
- 병원 밖 도움: 전국 지역암센터의 **암생존자통합지지센터**(☎ 1577-9740)에서 상담·심리지지·자기관리 프로그램을 운영합니다. 암 정보가 궁금하면 국가암지식정보센터 상담(☎ 1577-8899, 평일 9~18시)을 이용할 수 있습니다.

불안이 몰려올 때 5분 방법

1. **숨:** 4초 들이쉬고, 6초 내쉬기를 5번.
2. **이름 붙이기:** "지금 나는 ○○ 결과가 걱정된다"라고 소리 내거나 적기.
3. **내 몫 나누기:** 지금 내가 할 수 있는 일 1개(전화 1통, 서류 1장)와 의료진 몫을 나눠 적기.
4. **정보 시간 정하기:** 인터넷 검색은 하루 30분, 정해 둔 시간에만. 밤 검색은 불안을 키웁니다.

"내 탓일까?"라는 생각

암은 한 가지 원인으로 생기지 않습니다. 생활습관, 감염, 유전, 나이, 그리고 설명되지 않는 우연이 겹칩니다. **원인 찾기보다 지금부터의 계획**에 에너지를 쓰는 편이 나를 돕습니다. 가족이나 주변 사람이 원인을 따져 묻는다면 "지금은 치료 계획에 집중하고 싶어"라고 말해도 됩니다.

희망과 현실을 함께 들고 가기

통계(생존율)는 많은 사람의 평균이지 나 한 사람의 예언이 아닙니다. 궁금하다면 담당 의사에게 "제 병기와 상태에서 치료 목표가 무엇인가요?"라고 물어보세요. 들고 싶지 않은 정보는 "지금은 듣지 않겠다"고 말할 권리도 있습니다.

보호자에게

보호자가 첫 30일에 할 수 있는 가장 좋은 일

- **기록 담당:** 진료실에서 답을 적습니다. 환자는 듣는 데 집중할 수 있습니다.
- **일정 담당:** 검사·진료·서류 일정을 한 곳(달력·앱)에 모읍니다.
- **연락 창구:** 친척·지인에게 소식을 전하는 사람을 한 명으로 정하면 환자가 같은 이야기를 반복하지 않아도 됩니다.
- **결정은 환자:** 의견은 말하되, 치료 결정의 주인은 환자입니다.

피하면 좋은 말과 바꿔 쓸 말

피하면 좋은 말	바꿔 쓸 말
"긍정적으로 생각해야 나아"	"힘든 마음 그대로 말해도 돼"
"왜 검진을 안 받았어"	"지금부터 같이 챙기자"
"○○ 먹으면 낫는데"	"새로 먹고 싶은 게 있으면 의사 선생님께 같이 물어보자"
"너보다 더 힘든 사람도 있어"	"네가 힘든 건 힘든 거야"

아이에게 알릴 때

- 아이의 나이에 맞게, **짧고 사실대로:** "(엄마·아빠·할머니 등 아이가 부르는 호칭)가 몸에 아픈 혹이 생겨서 병원에서 치료를 받을 거야."
- 아이가 자주 하는 걱정 세 가지에 먼저 답합니다: **네 탓이 아니야 / 윗병이 아니야 / 누가 너를 돌봐줄지 정해져 있어.**
- 학교 담임에게 알릴지, 누가 알릴지 미리 정합니다.

보호자의 휴가 제도

일하는 보호자는 **가족돌봄휴직**(연간 최대 90일)과 그 안에서 하루 단위로 쓰는 **가족돌봄휴가**(연간 최대 10일)를 회사에 신청할 수 있습니다(남녀고용평등법,

2026.10 기준·고용노동부 확인). 진료 동행이 잦은 첫 30일에 특히 유용합니다.

보호자 자신을 위해

보호자의 소진은 흔합니다. 하루 30분은 나를 위한 시간을 지키세요. 병원
사회사업팀과 환우·보호자 모임은 보호자도 이용할 수 있습니다.

직장과 일상

- **언제·누구에게·얼마나** 말할지는 내가 정합니다. 직속 상사와 인사 담당자에게 "치료 일정 때문에 근무 조정이 필요하다" 정도만 알려도 충분한 경우가 많습니다.
- 치료 일정이 나오면 **근무 조정안**(단축근무, 재택, 연차·병가 조합)을 내가 먼저 제안하면 협의가 쉬워집니다.
- 피로는 치료 중 가장 흔한 증상입니다. 치료 직후 며칠은 일을 줄이는 계획을 미리 세웁니다.
- 자영업자라면 매출보다 **현금 흐름 3개월**을 먼저 계산하고, 사회사업팀에 지원제도를 문의합니다.
- 복귀는 한 번에 100%가 아니라 단계적으로. 복귀 시점은 담당 의사와 상의합니다.
- 암생존자통합지지센터(☎ 1577-9740)에는 직장·학교 복귀를 돕는 프로그램이 있습니다(지역별 운영 확인).

먹는 것과 움직이는 것

식사 원칙

- 치료 중 목표는 "특별한 음식"이 아니라 **체중과 근육 유지**입니다. 고른 식사와 충분한 단백질(생선·달걀·두부·살코기·유제품)을 챙깁니다.

- 암 치료에 특별히 좋은 음식이나 꼭 피해야 할 "나쁜 음식"이 따로 정해져 있지는 않습니다. "좋다는 음식"만 먹거나 여러 음식을 가리면 오히려 영양이 치우치고 체력이 떨어져 치료를 버티기 어려워집니다.
- 입안이 험했을 때는 잡곡밥보다 부드러운 흰쌀밥이 나올 수 있고, 체중이 줄고 있다면 기름을 지나치게 제한할 필요도 없습니다. 유기농 식품이 치료에 특별히 도움이 된다는 근거는 뚜렷하지 않습니다.
- 체중이 한 달에 5% 이상 줄거나 먹는 양이 평소의 절반 이하로 1주 이상 이어지면 영양 상담을 요청합니다.
- 항암치료 중 면역이 떨어질 때는 날음식·덜 익힌 고기·살균 안 된 유제품을 피하라는 안내를 받을 수 있습니다. 병원 안내를 따르세요.
- **건강기능식품·한약·즙·고용량 비타민**은 항암제나 수술·방사선과 상호작용하거나 간·신장에 부담을 줄 수 있습니다. 시작 전에 꼭 의료진과 약사에게 보여 주세요.

움직이기

- 걷기처럼 가벼운 활동은 피로와 기분을 개선하는 근거가 있습니다. 컨디션에 맞춰 하루 10분부터 시작합니다.
 - 일반적인 건강 목표는 주 150분 중간 강도 활동이지만, 치료 중에는 **할 수 있는 만큼**이 기준입니다.
 - 발열, 심한 빈혈·어지럼, 뼈 전이 통증, 수술 직후에는 운동 강도를 의료진과 상의합니다.
 - 담배는 상처 회복과 치료 효과, 다른 암 위험에 모두 영향을 줍니다. 금연 클리닉(보건소)과 금연상담전화 ☎ 1544-9030을 이용하세요.
-

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

- 1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
- 2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
- 3. **제도는 바뀔니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

1. 산정특례(중증질환 본인부담 경감)

항목	내용(2026.10 기준, 확인 필요)
대상	암으로 확진된 환자(림프종 포함). 상피내암(0기)·경계성 종양 등은 대상·비율이 다를 수 있어 원무과 확인
혜택	건강보험 급여 진료비의 본인부담 약 5%(입원·외래). 비급여·선별급여는 해당하지 않거나 비율이 다름
기간	적용 시작일(확진일 또는 신청일)부터 5년. 5년 뒤 남아 있는 암·재발·전이가 있으면 재등록 심사
신청 시한	확진일로부터 30일 이내 신청하면 확진일부터 적용. 그 뒤에 신청하면 신청일부터 적용
방법	진단한 의사가 산정특례 등록 신청서를 작성 → 대부분 병원 원무과가 공단에 전송. 직접 제출도 가능

확인할 것

- ☐ 병원이 대신 접수했는지, 등록 결과(문자·공단 앱)를 받았는지
- ☐ 다른 병원으로 옮겨도 산정특례는 유지됩니다. 새 병원 원무과에 등록 사실만 알리면 됩니다.
- ☐ 확진 전 검사비는 적용 시점에 따라 경감되지 않을 수 있습니다.

2. 의료비 부담을 덜어주는 제도

제도	핵심	문의
본인부담상한제	1년간 낸 건강보험 본인부담금이 소득 구간별 상한을 넘으면 남은 금액을 돌려받음(비급여 제외)	국민건강보험공단 1577-1000
재난적 의료비 지원	소득·재산 기준을 충족하고 의료비 부담이 큰 경우 일부 지원(비급여 일부 포함)	공단 지사·병원 사회사업팀
국가 암환자 의료비 지원	의료급여 수급자·차상위 등 해당자 대상 지원	주소지 보건소
병원 사회사업팀 (의료사회복지사)	후원 연계, 간병·교통·숙소 정보, 제도 신청 도움	진료 병원 사회사업팀

대상 기준과 금액은 해마다 바뀝니다. "내가 해당되는지"는 병원 사회사업팀에 한 번에 물어보는 것이 가장 빠릅니다.

3. 보험 청구 서류 체크리스트

민간 암보험(진단비)

- ☐ 진단서(질병분류코드 포함) — 보험사 양식이 있는지 먼저 확인
- ☐ 조직병리검사 결과지(병리보고서) — 대부분의 약관이 병리 확정을 요구합니다

- □ 약관에서 "**유사암·소액암**"(갑상선암, 제자리암/상피내암, 경계성 종양, 기타 피부암 등) 분류를 확인 — 진단비가 다를 수 있습니다
- □ 청구 기한(보험금 청구권 소멸시효는 3년)

실손의료보험

- □ 진료비 영수증 + 진료비 세부산정내역서(비급여 항목 확인용)
- □ 일정 금액 이상은 진단서·입퇴원확인서 추가
- □ 가입 시기에 따라 보장 범위(비급여 주사·도수 등)가 다릅니다

보험 상담에서 "진단서는 몇 통이 필요한가요?"를 먼저 물어보고, 병원에서는 한 번에 필요한 부수만큼 발급받으면 비용과 시간을 아낄 수 있습니다.

4. 회사·학교에 낼 서류

- □ 진단서 또는 소견서(치료 예정 기간 포함 여부 확인)
- □ 회사 취업규칙의 **병가·질병휴직** 조항 확인 — 법정 의무 병가는 없고 회사 규정에 따름(공무원·교원은 별도 규정)
- □ 상병수당: 일부 지역 시범사업 중 — 거주 지역·자격을 공단에 확인
- □ 개인 의료정보는 **필요한 만큼만** 알립니다. 병명 공개 범위는 내가 정합니다 (PART 4 「직장과 일상」 참고).

5. 진료 서류 모아두기(2차 소견·전원 대비)

서류	어디서	메모
병리보고서(조직검사 결과지)	진단 병원 의무기록팀	바이오마커 결과 포함 여부
병리 슬라이드·파라핀 블록 대여	진단 병원 병리과	다른 병원 재판독·추가검사에 필요. 반납 기한 확인

서류	어디서	메모
영상 CD + 판독지	진단 병원 영상의학과· 의무기록팀	CT·MRI·PET 모두
혈액검사 결과	의무기록팀	최근 것
진료의뢰서(소견서)	담당 의사	상급종합병원 외래는 의뢰서가 있어야 건강보험 적용

림프종 참고: 질병코드는 호지킨 C81, 비호지킨 C82~C86 등 아형에 따라
다릅니다. 관찰만 하는 저등급 림프종도 산정특례 대상인지, 등록 시점과 5년
후 재등록 조건을 원무과에 확인하세요. CAR-T 등 세포치료는 시행 기관과
급여 기준을 의뢰 전에 확인합니다.

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 정확한 아형은요? 2. 병기와 B증상·큰 덩이 여부는요? 3. 바로 치료인가요, 관찰인가요? 4. 치료 요법과 주기는요? 5. B형간염 검사 결과와 예방약은요? 6. 가임력 보존 시간이 있나요? 7. 중간 PET은 언제 하나요? 8. 방사선이 필요한가요? 9. 바로 연락해야 할 증상은요? 10. 재발하면 CAR-T·이중특이항체 같은 선택지가 있나요?

내 림프종 한 장 요약

항목	내 기록
아형	_____
병기	_____ (B증상 ☐ / 큰 덩이 ☐)
LDH	_____
B형간염	HBsAg _ / <i>anti-HBc</i> _ · 예방약 _____
첫 치료	항암(요법 _____) / 관찰 / 방사선 / 제균
주기	_ 주기 중 _
가임력	해당 없음 / 상담 / 완료
산정특례	☐ 신청 ☐ 완료

오늘 꼭 물을 3가지: ① 제 아형은? ② 치료인가요, 관찰인가요? ③ B형간염 예방약이 필요한가요?

같은 진단, 다른 30일 (가상 사례)

감수단 환자 페르소나를 바탕으로 재구성한 가상의 이야기입니다.

29세 하늘 씨 — 진행기 호지킨, 대학원생 첫 항암 전에 정자 동결을 마쳤고, 지도교수에게는 "6개월 치료 일정"만 알렸다. 면역치료 병용 요법의 부작용 카드를 지갑에 넣었다. "완치율이 높다는 말과 지금 무섭다는 마음이 둘 다 진짜라는 걸 인정했어요."

64세 명숙 씨 — DLBCL, B형간염 과거력 "옛날에 앓고 나온 간염이 왜 문제냐"고 물었다. 핵심항체 양성이라 예방약을 함께 시작했고, 치료가 끝나도 한동안 먹기로 했다. "약을 끊지 말라는 한 줄을 냉장고에 붙였어요."

70세 기철 씨 — 저등급 여포성, 관찰 권유 "암인데 치료를 미뤄도 되냐"는 질문에, 담당의는 관찰이 근거 있는 전략이라고 설명했다. 관찰 일지에 림프절 크기와 체중을 적는다. "지켜보는 것도 제 치료의 일부라고 생각하니 마음이 놓입니다."

용어사전

용어	쉬운 뜻
호지킨 / 비호지킨 림프종	림프종의 두 큰 갈래
DLBCL	미만성 거대B세포 림프종, 가장 흔한 공격성 림프종
여포성·변연부 림프종	천천히 자라는 림프종
종심부 조직검사	굵은 바늘로 조직을 얻는 검사
Lugano 병기	림프종 병기 체계

용어	쉬운 뜻
Deauville 점수	PET 반응평가 점수(1~5)
B증상	발열·식은땀·체중 감소
항CD20 항체	B세포 림프종 표적 항체(리툰시맙 등)
HBsAg / anti-HBc	B형간염 표면항원 / 핵심항체
종양용해증후군	암세포가 한꺼번에 깨지며 생기는 대사 이상
CAR-T	환자 면역세포를 조작해 넣는 세포치료
이종특이항체	암세포와 면역세포를 잇는 항체
사이토카인방출증후군	세포치료 후 발열·저혈압 등 면역 반응
관찰(watch and wait)	치료가 필요할 때까지 정기 검사로 지켜보는 전략
자가조혈모세포이식	고용량 항암 뒤 미리 모아 둔 내 조혈모세포를 다시 넣는 치료
Ann Arbor 병기	림프종의 전통적 병기 체계(Lugano의 바탕)

자주 묻는 질문 12

Q1. 림프종은 혈액암인가요? 림프구(면역세포)에서 생기는 암으로 혈액암으로 분류되며, 혈액종양내과에서 치료합니다.

Q2. 림프절 하나만 커졌는데 왜 전신 검사를 하나요? 림프종은 여러 곳에 동시에 있을 수 있어 PET/CT로 전체 범위를 확인해야 치료를 정할 수 있습니다.

Q3. 관찰만 하라는데 정말 괜찮나요? 천천히 자라는 림프종에서 증상이 없을 때 일찍 치료해도 생존이 늘지 않는다는 근거가 있습니다. 정기 검사로 필요한 때를 놓치지 않습니다.

Q4. 항암 중 백혈구 촉진 주사는 왜 맞나요? 백혈구 감소 기간을 줄여 감염 위험을 낮추기 위해서입니다. 뼈가 쑤시는 통증이 생길 수 있습니다.

Q5. 중간 PET 결과가 좋으면 치료를 줄이나요? 호지킨 림프종 등 일부에서는 중간 PET 결과로 치료 강도나 방사선 여부를 조정합니다.

Q6. 완전관해면 완치인가요? 완전관해는 검사에서 암이 보이지 않는 상태로 좋은 신호이지만, 완치 여부는 시간을 두고 추적하며 판단합니다.

Q7. 머리카락은 다 빠지나요? 요법에 따라 다릅니다. R-CHOP 계열은 탈모가 흔하고, 치료 후 다시 자랍니다.

Q8. 스테로이드 때문에 잠이 안 오고 배가 고파요. 흔한 부작용입니다. 아침에 복용하고(지시대로), 혈당을 확인하세요. 불면이 심하면 알리세요.

Q9. 치료 후 아이를 가질 수 있나요? 요법에 따라 생식 기능 영향이 다릅니다. 첫 항암 전 정자·난자 보존을 상의하고, 치료 후 임신 시기는 담당의와 정하세요.

Q10. CAR-T는 언제 받나요? 주로 1차 치료 후 재발하거나 반응이 없을 때 고려합니다. 시행 기관과 조건을 미리 확인하세요.

Q11. 사람 많은 곳에 가도 되나요? 백혈구가 낮은 시기에는 피하는 것이 좋습니다. 마스크와 손 씻기를 생활화하세요.

Q12. 학교·회사는 쉬어야 하나요? 요법과 체력에 따라 다릅니다. 3주 주기 중 컨디션이 좋은 주를 활용해 일부 병행하는 사람도 있습니다.

진료실 대화법: 15분 진료를 30분처럼

30초 요약: 질문은 3개로 줄여 가져가고, 보호자가 적고, 마지막에 "제가 이해한 것이 맞는지 말해 볼게요"로 확인합니다.

진료 전날

- 질문 3개를 우선순위로 적기(워크북 W2)
- 지난 진료 이후 바뀐 증상·약을 한 줄씩
- 검사 결과지·영상 CD·복용 약 목록 챙기기

진료실에서

- 1. 첫 문장으로 가장 중요한 것부터: "오늘 가장 궁금한 건 첫 치료가 무엇이고 언제 시작하는지예요."
- 2. 어려운 말이 나오면: "그 말을 쉽게 다시 설명해 주시겠어요?" "종이에 적어 주실 수 있나요?"
- 3. 선택지가 나오면: "선택지마다 장점과 단점, 그리고 선생님이라면 무엇을 고르실지 여쭙봐도 될까요?"
- 4. 끝나기 전: "제가 이해한 대로 말해 볼게요. ○○하고, 다음은 ○월 ○일 ○○ 검사죠?"
- 5. 연락처: "집에서 문제가 생기면 누구에게 연락하나요?"

녹음하고 싶다면

진료 내용을 기억하기 위해 녹음하고 싶을 때는 먼저 의료진에게 양해를 구하세요. 허락이 어려우면 보호자 기록으로 대신합니다.

다학제 진료

여러 과(수술·종양내과·방사선종양학과·영상의학과·병리과 등)가 한자리에서 치료를 상의하는 진료입니다. 치료 선택지가 여럿이거나 순서가 중요한 경우 "다학제 진료를 받을 수 있나요?"라고 물어보세요.

검사 준비 카드

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
CT(조영)	몇 시간 금식(병원 지시), 물 충분히(제한 없을 때)	조영제 알레르기, 신장 기능 저하, 당뇨약 (메트포르민), 임신 가능성	촬영은 10~20분

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
MRI	금속 제거, 일부는 금식	심박동기·인공와우·몸속 금속, 폐소공포증(진정 상담), 신장 기능	30~60분
PET/CT	(FDG PET) 4~6시간 금식, 전날 격한 운동 피하기 · 다른 종류의 PET은 병원 안내	당뇨(혈당 조절법 미리 확인), 임신·수유	주사 후 대기 포함 2~3시간
조직검사 (바늘)	금식 여부 확인	혈액을 묽게 하는 약(중단 여부는 의료진 지시), 알레르기	시술 후 관찰 수시간
내시경	금식, 대장은 장 정결제	혈액을 묽게 하는 약, 당뇨약	진정 시 보호자 동행·당일 운전 금지
뼈스캔	주사 후 물 많이 마시기	임신·수유	주사 후 2~4시간 대기

검사 결과는 "검사를 한 날"이 아니라 **"결과 설명을 듣는 날"**을 미리 예약해 두면 기다리는 불안이 줄어듭니다.

워크북

이 장은 오려 쓰거나 복사해 쓰도록 만들었습니다. 진료실에는 이 페이지만 들고 가도 됩니다.

W1. 비상 연락처 카드 (휴대폰 사진으로도 저장)

항목	기록
담당 교수 / 진료과	
평일 진료실·외래 간호사실 ☎	
야간·휴일 연락처 ☎	
가까운 응급실(치료 병원 우선)	
항암·방사선 치료실 ☎	
보호자 1 / 보호자 2 ☎	
국가암지식정보센터 암정보 상담(평일 9~18시)	☎ 1577-8899
암생존자통합지지센터(지역암센터)	☎ 1577-9740
응급 119 · 정신건강 위기 109	

W2. 진료 기록지 (진료마다 1장)

항목	기록
날짜 / 진료과 / 의사	
오늘 들은 진단·병기	✓ / ⏳ / ?
오늘 결정된 것	
다음 검사·날짜	
다음 진료 날짜	
새로 받은 약	
꼭 지켜야 할 주의사항	

항목	기록
다음에 물어볼 것	

W3. 7일 증상 일지

날 짜	체온 (최고)	통증 0~10	식사(평소의 %)	배변· 배뇨	잠	기분 0~10	메모·연락 여부

W4. 복용 약·보충제 목록 (모든 진료에 지참)

이름	용량·횟수	왜 먹나	처방한 곳	의료진에 알림
				☐
				☐
				☐
				☐

혈액을 묽게 하는 약(항응고제·항혈소판제), 당뇨약, 한약·건강기능식품은
수술·시술·항암 전에 특히 중요합니다.

W5. 30일 체크 달력

주	날짜	한 일(✅) / 남은 일(⌚)
1주(Day 0-7)		

주	날짜	한 일(🟢) / 남은 일(🕒)
2주(Day 8-14)		
3주(Day 15-21)		
4주(Day 22-30)		

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — B-Cell Lymphomas / Hodgkin Lymphoma / T-Cell Lymphomas, Version 4.2026(B세포 림프종 기준). NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 림프종 정보, 대한혈액학회 림프종연구회 자료, 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 쓰지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **참고문헌:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터, 림프종 정보(확인일 2026.10.04). 사실 확인용 참고문헌이며, 국가암지식정보센터의 저작물을 수록하지 않았습니다. 독자 안내: 공식 암 정보와 무료 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899.
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.
- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허

의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.

- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>